

Vaginitis bacteriana, candidiasis y tricomoniasis

1. Introducción y relevancia clínica

El **flujo vaginal anormal** es una de las **consultas más frecuentes** en ginecología y atención primaria.

Aunque la mayoría de las leucorreas son benignas, pueden causar **malestar, prurito, dispareunia y mal olor**, y su correcta identificación evita tratamientos erróneos o incompletos.

Las **tres causas infecciosas más comunes** de flujo vaginal son:

1. **Vaginosis bacteriana (VB)**
2. **Candidiasis vulvovaginal (CVV)**
3. **Tricomoniasis vaginal (TV)**

Cada una tiene características clínicas, diagnósticas y terapéuticas específicas, y conocerlas permite **distinguir las rápidamente** en el examen clínico, algo que EUNACOM evalúa con frecuencia.

☐ En el examen suelen preguntar:

“¿Cuál es el diagnóstico más probable ante flujo grisáceo con olor a pescado?”

o “¿Qué tratamiento usarías en una embarazada con candidiasis vaginal?”

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Microbiota vaginal normal

En condiciones fisiológicas, la vagina alberga una **flora dominada por Lactobacillus spp.**, que:

- Producen **ácido láctico**, manteniendo un **pH ácido (3,8–4,5)**.
- Secretan **peróxido de hidrógeno y bacteriocinas**, que inhiben patógenos.
- Mantienen un equilibrio hormonal dependiente de estrógenos.

Cuando este equilibrio se altera (por antibióticos, relaciones sin protección, duchas vaginales, embarazo, etc.), puede proliferar flora patógena y producir infección.

3. Principales causas de flujo vaginal patológico

Etiología	Agente principal	pH vaginal	Olor	Flujo característico
Vaginosis bacteriana	<i>Gardnerella vaginalis</i> (flora mixta anaerobia)	>4,5	Pescado / aminas	Grisáceo, homogéneo, sin prurito
Candidiasis	<i>Candida albicans</i>	<4,5 (normal)	No	Grumoso, blanco, prurito intenso
Tricomoniasis	<i>Trichomonas vaginalis</i> (protozoo)	>4,5	Maloliente	Amarillo-verdoso, espumoso, prurito, eritema

□ **Regla práctica:**

- *pH bajo* → Candidiasis.
- *pH alto* → Vaginosis o Tricomoniasis.

4. Clínica y diagnóstico diferencial

A.

Vaginosis bacteriana (VB)

Etiología:

Desequilibrio de la flora vaginal con sobrecrecimiento de *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma hominis* y anaerobios (*Mobiluncus*, *Bacteroides*).

Factores de riesgo:

- Relaciones sexuales sin protección.
- Uso de duchas vaginales.
- Antibióticos recientes.
- Dispositivos intrauterinos.
- Embarazo.

Clínica:

- Flujo **grisáceo, homogéneo, maloliente** (“olor a pescado”).
- Sin prurito ni eritema.
- Olor aumenta tras el coito (liberación de aminas alcalinas).

Diagnóstico (criterios de Amsel – requiere 3 de 4):

1. Flujo homogéneo, blanco-grisáceo.
2. pH vaginal >4,5.
3. Olor a aminas tras KOH 10% (“test del olor”).
4. Presencia de “clue cells” (células epiteliales recubiertas de bacterias en frotis).

Tratamiento:

- **Metronidazol 500 mg VO cada 12 h por 7 días** (esquema de elección MINSAL).
- Alternativa: Clindamicina 2% crema intravaginal 5 g por 7 días.
- En embarazo: mismo esquema oral (seguro).
- Tratar parejas solo si hay síntomas (raro).

B.

Candidiasis vulvovaginal (CVV)

Etiología:

Infección por *Candida albicans* (>85%), hongo oportunista del microbioma vaginal.

Factores predisponentes:

- Uso de antibióticos de amplio espectro.
- Diabetes mellitus mal controlada.
- Embarazo.
- Uso de anticonceptivos combinados.
- Inmunosupresión.

Clínica:

- Flujo **blanco, espeso, grumoso (“tipo yogur”)**, sin olor.
- Prurito vulvar intenso, ardor, dispareunia.
- Eritema y edema vulvar marcados.
- pH vaginal normal (<4,5).

Diagnóstico:

- Examen con KOH 10% → visualización de hifas o blastosporas.
- pH normal.
- Diagnóstico clínico habitual.

Tratamiento:

- **Clotrimazol 500 mg óvulo vaginal dosis única o**
Clotrimazol 100 mg óvulo vaginal por 7 días.
- Alternativa oral: **Fluconazol 150 mg VO dosis única.**
- En embarazadas: solo tópicos (evitar azoles orales).

□ En EUNACOM: “Embarazada con flujo blanquecino grumoso y prurito → Clotrimazol vaginal.”

Recurrencia (>4 episodios/año):

- Fluconazol 150 mg VO semanal por 6 meses.
 - Control de glicemia y factores predisponentes.
-

C.

Tricomoniasis vaginal (TV)

Etiología:

Protozoo flagelado *Trichomonas vaginalis*, transmitido sexualmente.

Infección frecuente en mujeres jóvenes sexualmente activas.

Clínica:

- Flujo **amarillo-verdoso, espumoso, fétido.**
- Prurito, ardor, disuria.
- Eritema intenso y “cérvix en frutilla” (punteado hemorrágico).
- pH >4,5.

Diagnóstico:

- Visualización directa del parásito móvil en fresco (frotis salino).
- pH elevado.
- Test rápidos o cultivo en medios especiales.
- ITS asociada → tamizar otras infecciones (gonorrea, clamidia, VIH).

Tratamiento:

- **Metronidazol 2 g VO dosis única** (elección MINSAL).
- Alternativa: Metronidazol 500 mg VO cada 12 h por 7 días.
- **Tratar a la pareja sexual simultáneamente.**

- Evitar alcohol durante tratamiento (reacción tipo disulfiram).

□ EUNACOM clásico: “Flujo verdoso, espumoso, pH >4,5 y cérvix en frutilla → Tricomoniasis → Metronidazol 2 g VO dosis única.”

5. Diagnóstico diferencial general

Característica	Vaginosis bacteriana	Candidiasis	Tricomoniasis
Causa	Desequilibrio flora anaerobia	Hongo <i>Candida</i>	Protozoo <i>Trichomonas</i>
pH vaginal	>4,5	<4,5	>4,5
Olor	Aminas (pescado)	No	Maloliente
Flujo	Gris homogéneo	Blanco grumoso	Amarillo-verdoso, espumoso
Prurito	No	Intenso	Intenso
Tratamiento	Metronidazol oral 7 días	Azoles tópicos/orales	Metronidazol dosis única
Pareja sexual	No se trata	No	Sí, siempre

6. Complicaciones y consecuencias

Infección	Complicaciones principales
Vaginosis bacteriana	EPI, parto prematuro, RPM, bajo peso al nacer, mayor riesgo de VIH
Candidiasis	Vulvovaginitis crónica, dispareunia, sobreinfección secundaria
Tricomoniasis	EPI, infertilidad, parto prematuro, coinfección por VIH

En embarazadas, tanto VB como TV se asocian a complicaciones obstétricas → **tratar siempre**.

7. Manejo en embarazadas

Infección	Tratamiento recomendado	Evitar
Vaginosis bacteriana	Metronidazol 500 mg VO c/12 h × 7 días	—
Candidiasis	Clotrimazol tópico 500 mg óvulo × 1 o 7 días	Fluconazol VO
Tricomoniasis	Metronidazol 2 g VO dosis única	Alcohol

☐ En embarazadas, el metronidazol es **seguro** en cualquier trimestre (categoría B FDA).

8. Prevención

- Evitar duchas vaginales.
- Uso de preservativo.
- Tratamiento adecuado de parejas (TV).

- Control de glicemia en diabéticas.
 - Evitar uso indiscriminado de antibióticos.
 - Educación sobre higiene vulvar y sexualidad segura.
-

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **VB:** pH >4,5, olor a pescado, flujo gris, “clue cells”, metronidazol 7 días.
2. **Candidiasis:** pH normal, flujo blanco grumoso, prurito intenso, clotrimazol o fluconazol.
3. **Tricomoniasis:** pH >4,5, flujo verdoso espumoso, “cérvix en frutilla”, metronidazol 2 g VO DU.
4. En embarazadas: **solo tratamientos tópicos o metronidazol oral**, según caso.
5. **Tratar pareja** solo en tricomoniasis.
6. **Metronidazol y alcohol** → **reacción disulfiram**.



Errores comunes

- Tratar candidiasis con metronidazol.
 - No tratar pareja en tricomoniasis.
 - Diagnosticar VB sin confirmar pH o clue cells.
 - Usar fluconazol en embarazo.
 - Confundir flujo fisiológico con patológico (pH y olor son claves).
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **VB, Candidiasis y Tricomoniasis** son las tres principales causas de flujo vaginal patológico.
2. **VB:** pH >4,5, olor a aminas → **Metronidazol oral 7 días.**
3. **Candidiasis:** pH normal, flujo blanco grumoso, prurito → **Clotrimazol o Fluconazol.**
4. **Tricomoniasis:** pH >4,5, flujo espumoso verdoso → **Metronidazol 2 g VO DU + tratar pareja.**
5. En **embarazadas**, usar **metronidazol oral o clotrimazol tópico.**
6. **No es necesario tratar parejas en VB o candidiasis.**
7. Toda mujer con flujo debe recibir **educación sexual, prevención de ITS y control posterior.**